

Ernährung: das Muster zählt.

Keine einzelne Zutat macht gesund oder krank. Entscheidend ist, was du über Wochen und Jahre regelmäßig isst. Vorne prüfst du dein Muster, hinten stehen Teller, Tausch-Ideen und Mengen für die Woche.

1 DEINEN KÖRPER EINORDNEN: TAILLE VOR GEWICHT

	günstig	erhöht	hoch
Taille geteilt durch Größe	unter 0,5	0,5–0,59	ab 0,6
Taille Männer	unter 94 cm	94–101 cm	ab 102 cm
Taille Frauen	unter 80 cm	80–87 cm	ab 88 cm
BMI	18,5–24,9	25–29,9	ab 30

Deine Taille, auf Nabelhöhe, ausgeatmet

 cm

Deine Größe

 cm

Taille geteilt durch Größe

Bauchfett ist stoffwechselaktiv und belastet Herz, Leber und Blutzucker stärker als Fett an Hüften und Beinen. Deshalb sagt die Taille mehr als der BMI, besonders bei muskulösen Menschen.

2 DEIN ERNÄHRUNGS-CHECK NACH ESC-EMPFEHLUNG

Kreuze an, was für eine normale Woche zutrifft.

- | | |
|--|--|
| ☐ Gemüse: mindestens 200 g am Tag | ☐ Rotes Fleisch höchstens 350–500 g pro Woche, Wurst selten |
| ☐ Obst: mindestens 200 g am Tag | ☐ Oliven- oder Rapsöl statt Butter und Schmalz |
| ☐ Vollkorn statt Weißmehl, 30–45 g Ballaststoffe | ☐ Salz unter 5 g, Fertiggerichte selten |
| ☐ Hülsenfrüchte mehrmals pro Woche | ☐ Keine gezuckerten Getränke |
| ☐ Nüsse: eine Handvoll, 30 g, ungesalzen | ☐ Alkohol unter 100 g pro Woche, weniger ist besser |
| ☐ Fisch 1–2 × pro Woche, einmal fettreich | ☐ Stark verarbeitete Snacks selten |

10 bis 12 Haken: sehr gutes Muster · **6 bis 9:** gute Basis, gezielt ergänzen · **unter 6:** hier liegt dein größter Hebel. Orientierung, kein geprüfter Fragebogen.

3 WARUM ES SICH LOHNT

–30 %

Herzinfarkt, Schlaganfall und Herztod mit Mittelmeerkost plus Olivenöl oder Nüssen

1 von 5

Todesfällen weltweit hängt mit ungünstiger Ernährung zusammen

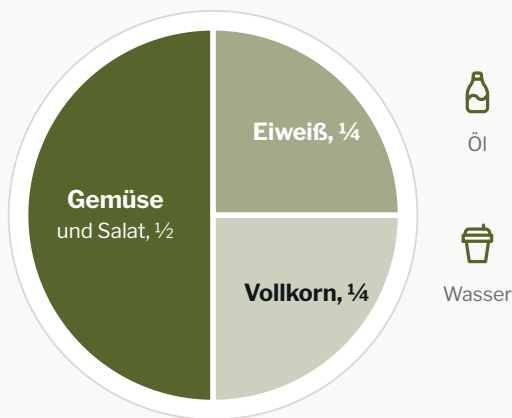
5 g

Salz am Tag sind die Obergrenze; die meisten essen fast das Doppelte

4 WAS DIE STUDIEN SAGEN

- **Intervallfasten** wirkt etwa so gut wie jede andere Art, weniger zu essen. Wenn es dir leichter fällt: gut.
- **Nahrungsergänzung** ersetzt kein Muster. Sinnvoll nur bei nachgewiesenem Mangel.
- **Eiweiß** ab etwa 65 mehr: 1,0 bis 1,2 g pro kg Körpergewicht, um Muskeln zu erhalten.
- **Kaffee** in üblichen Mengen, etwa 3 Tassen am Tag, gilt als unbedenklich.

5 WAS DU SELBST TUN KANNST: TELLER UND TAUSCH



Eiweiß: Hülsenfrüchte, Fisch, Geflügel, Eier, Tofu, Joghurt. Beilage: Vollkornbrot, -reis, -nudeln oder Kartoffeln.

STATT	LIEBER
Weißbrot, Toast	→ Vollkornbrot, Haferflocken
Butter, Schmalz	→ Oliven- oder Rapsöl
Wurst aufs Brot	→ Hummus, Frischkäse, Ei
Chips, Kekse	→ Nüsse, Obst, Gemüsesticks
Fruchtjoghurt	→ Naturjoghurt mit Beeren
Limo, Saft	→ Wasser, Tee, Schorle 1:3
Fertigpizza	→ Linsen- oder Bohneneintopf



5 x

Gemüse und Obst am Tag, bunt gemischt



3 x

Hülsenfrüchte pro Woche



1–2 x

Fisch pro Woche



30 g

Nüsse am Tag



5 g

Salz am Tag, höchstens

6 WANN ÄRZTLICHE BEHANDLUNG DAZUKOMMT

BMI 25–29,9

→ Ernährung, Bewegung, Schlaf. Ziel: 5 bis 10 % weniger Gewicht, vor allem Taille.

BMI ab 30

→ Oder ab 27 mit Begleiterkrankung: zusätzlich Medikamente zur Gewichtsabnahme möglich.

BMI ab 40

→ Oder ab 35 mit Begleiterkrankung: auch eine Operation kommt infrage.

7 KONTROLLE

Taille einmal im Monat, Gewicht einmal pro Woche, morgens nüchtern. Blutfette und Langzeitzucker nach drei Monaten neuer Ernährung prüfen.

8 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- ☐ Ernährungs-Check machen, einen Punkt wählen
- ☐ Einen Tausch aus der Liste für vier Wochen

9 PASSENDE HANDOUTS



Cholesterin

LDL, ApoB, Lp(a)



Blutdruck

Messen und senken



Zucker und Niere

HbA1c, Glukosekurve



Krafttraining

Eiweiß und Muskeln



Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf
0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro

Quellen: Visseren FLJ et al., 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention, Eur Heart J 2021 · Estruch R et al., PREDIMED, NEJM 2018 · Afshin A et al., GBD 2017 Diet Collaborators, Lancet 2019 · NICE, Obesity: identification and classification, 2022 · WHO, Waist circumference and waist-hip ratio, 2008 · Bauer J et al., PROT-AGE, J Am Med Dir Assoc 2013.